

시청 관영 콘텐츠



토혈로 내원 시 가장 먼저 기침 유발인지 확인 후 **객혈과 감별**합니다.

이후에 색깔, 거품 여부, 음식 여부, 기침 유발 여부 등을 바탕으로 문진이 필요합니다. 또한 토혈의 경우 응급 상황일 수도 있으므로 **토혈의 양과 응급 증상에** 해

당하는 **어지럼증, 호흡곤란, 소변량 감소** 등을 물어보고 해당 증상을 호소하는 경우 수액을 달아 준다는 언급을 한다면 의사-환자 관계에서 좋은 점수를 얻을 수 있을 것입니다.

토혈 증례에서는 **말로리-바이스 증후군과 감별하는 것이 중요하므로 음주력을 물어보는 것**을 잊지 마세요. 상하부 위장관 출혈에서는 **변 색깔**이 중요한 감별점이 됩니다. 또한 출혈과 관련된 경우 출혈 경향성과 **관련 약물(NSAIDs, 항응고제)**도 잊지 말고 물어보세요.

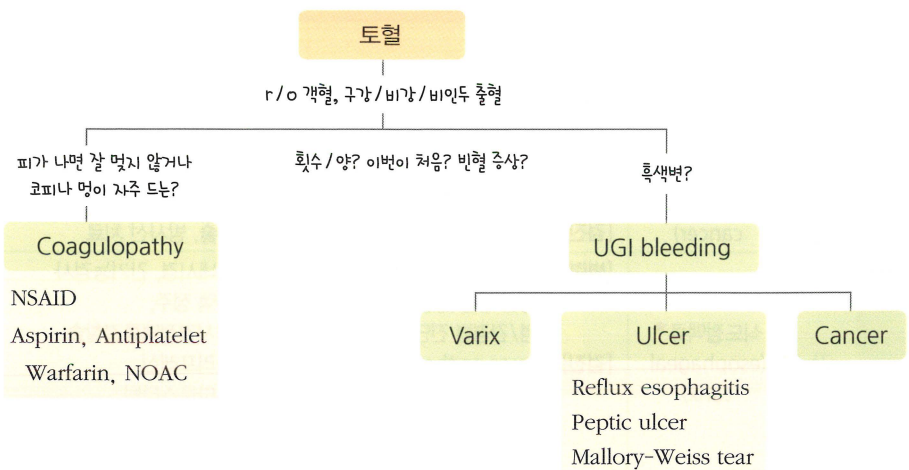
토혈이나 객혈, 혈소 등 피가 나올 수 있는 상황들에 대해서는 환자들이 많이 놀라고 당황하는 기색을 보이는데, 이를 잘 이해하고 진정시켜 주는 태도 또한 의사-환자 관계에 중요합니다. 신체 진찰에선 우선 혈압, 맥박을 확인하여 응급 상황인지 판단하여야 합니다. 또한 식도정맥류 출혈 감별을 위해 피부의 Flapping tremor, 흉부 진찰 시 가슴까지 옷을 올려 거미혈관종을 확인하는 등 **간질환 관련 신체 검진을 빼먹지 않는 것이 중요합니다**. Flapping tremor나 Shifting dullness처럼 특징적인 신체 검진을 충분히 연습해 두면 도움이 될 것입니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
식 도	-	역류 식도염 (reflux esophagitis)	[병력] 소량의 피, 신물이 올라옴, 속쓰림 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 24시간 식도 pH검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
	-	식도암★ (esophageal cancer)	[병력] 담배를 많이 피, 나이 많음, 연하곤란, 체중 감소 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 흉부 CT [치료] 수술, 방사선 치료
	간	식도정맥류★ (esophageal varix)	[병력] 많은 양의 토혈, 간경변 증상(황달, 복부 팽만), 간염/간경변 진단 [검진] Palmar erythema, 복수, Flapping tremor, Spider angioma, Caput medusae	[검사] 위내시경, 간기능검사 [치료] 수액 정주, 내시경정맥류결찰술, 털리프레신, 소마토스타틴, 베타 차단제(예방 목적)

위	음주	말로리-바이스 증후군★ (mallory-weiss syndrome)	[병력] 음주 후 구토하던 중 토혈 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경 [치료] 수액 정주 및 안정
	-	위궤양★ / 십이지장궤양★	[병력] 식전/후 속쓰림, 많은 양의 토혈, 소화불량 [검진] 상복부 압통	[검사] 위내시경, 신속요소분해효소검사 [치료] (대량 토혈) 내시경지혈술, 양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제, 교육
	-	소화성 궤양 천공	[병력] 식전/후 속쓰림, 다량 토혈, 소화불량+발열, 오한, 심한 복통 [검진] 복부 전체 압통/반발 압통	[검사] 흉부 X-ray, 복부 CT [치료] 응급 개복 수술
	-	위암★	[병력] 체중 감소, 소화불량, 속쓰림(증상 없을 수도) [검진] 특이 소견 없을 수 있음	[검사] 위내시경, 복부 CT [치료] 위절제술, 내시경점막절제술, 항암 치료
혈액	-	응고장애	[병력] 출혈 경향, 아스피린 등 약제 복용력	-

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 취취

O	언제 피를 토하셨나요?/갑자기 발생했나요?/어떤 상황에서 피를 토했나요?
L	-
D	몇 번이나 피를 토하셨나요?
Co	피의 양이 점점 늘어나나요? → 심해지고 있나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 있으셨나요? 그때는 치료를 받으셨나요?
C	[객혈과 감별] 거품이 있었나요?/기침하다가 토해진 않았나요? 코나 입에서 피가 나오진 않았나요?/음식물이 섞여 있었나요? 가래가 섞여 있었나요? 암기법 거기 코와 입에 응가 설명 코나 입에서 나는 피는 출혈 경향 associated symptoms에 포함됨 출혈량이 얼마나 되나요? (소주잔 또는 종이컵 기준) 색깔은 어떤가요? (선홍색/검붉은색)/피떡이 있었나요?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 감소(식도암, 위암 감별) [과다 출혈, 탈수] 목마름/호흡곤란/두근거림/어지럼증/소변량 감소가 있나요? 암기법 마른 호두를 어지럽힌 소감 설명 마른(목마름) 호두(호흡곤란, 두근거림)를 어지럽힌(어지럼) 소감(소변량 감소) [출혈 경향] 멍이 잘 들/코피, 출혈 후 잘 안 멎음/생리량이 많아졌나요? 암기법 멍 때리니까 코피가 안 멎지 설명 멍(멍이 잘 들) 때리니까 코피(코나 입에서 피)가 안 멎지(출혈 후 안 멎음) [소화기] 식욕 저하/구역감/설사/변비/흑색변/혈변/명치 통증/소화불량이 있나요? [역류 식도염/식도암] 신물 올라옴/속쓰림/연하곤란이 있나요? [식도정맥류 파열] 황달/복부 팽만/소변색이 진해졌나요?/대변색 변화가 있나요? [말로리-바이스] 토하기 전에 과음하셨나요?
F	[악화] 통증이 있다면 식사와 관련 있나요?

E	이전에 건강 검진 해 보셨나요?/위내시경도 하셨나요?/간염 예방접종은 다 맞으셨나요?
외	복부 수술 받으신 적 있나요?/복부를 다친 적이 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (소화기 질환)
약	복용 중인 약물이 있나요?/피를 묽게 하는 약(아스피린 등) 먹고 있나요?
사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요?/맵거나 자극적인 음식을 좋아하시나요? [운동] 운동은 규칙적으로 하시나요?/일주일에 몇 번 정도 하세요?
가	가족 중 간질환이 있는 분 있나요? 가족 중 소화기계 관련 질환 있으신 분 있었나요?
여	[월경력] LMP/규칙적/주기/생리량/생리통/임신 가능성
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [출혈★] 혈압, 맥박 보고 응급인지 확인하는게 먼저 [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 코★ : 비경 이용하여 비강 내 출혈 확인 3. 입★ : 혀 탈수 소견, 구강 내 출혈, 인두에 피떡 확인 ☞ 설암자조 구강의 출혈을 확인합니다. 4. 목 : 경부 림프절 촉진 + 가슴 사진(spider angioma) 5. 손(피부)★ : 피부 긴장도, Palmar erythema, Flapping tremor [누워서] 6. 복부(간)★ [시진] 수술 흔적/복부 팽만/Spider angioma/Caput medusae [청진] 차가우실 수 있어요./5구역, 3초씩 [타진] 타진 4군데/간, 비장 타진/복수(shifting dullness) [촉진] Superficial 4군데, Deep 4군데, 통증 있으면 반동 압통도/간, 비장 촉진 7. DRE : 직장수지검사
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 피를 토하셔서 많이 놀랐을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 말로리-바이스 증후군이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 역류식도염, 위궤양 등을 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 위내시경검사가 필요하고, 전체혈구검사, 전해질검사 등 혈액 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 말로리-바이스 증후군이 확진되면 치료를 위해 금식과 수액 치료가 필요하고, 출혈이 심한 경우 내시경적 치료가 필요할 수 있습니다. 만약 식도정맥류 출혈이 확인되면 정도에 따라 내시경정맥류결찰술을 시행할 수 있고, 간경변에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	위내시경을 시행하기 위해서 8시간 이상 금식하셔야 합니다. 출혈이 심하면 어지럼/호흡곤란 등이 발생할 수 있는데, 그럴 경우 응급 상황이니 병원으로 바로 내원하시길 바랍니다. 술을 드시면 상태가 점점 악화될 것이고 재발할 수 있기 때문에 반드시 금주하셔야 합니다. 간경변이 잘 조절되지 않으면 식도정맥류 출혈이 재발할 수 있습니다. 그런 경우 혈관조영술을 통한 시술이 필요할 수 있습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, 전해질, LFT, 혈액응고검사
- ② 위식도내시경, 요소날숨검사, Chest X-ray, 복부 X-ray, 혈관조영술

❖ 치료 계획

- ① 출혈 : 수액 치료(심하면 수혈)
- ② 내시경적 지혈술, 금식
- ③ 소화성 궤양 : PPI, *H. pylori* 치료
- ④ 식도정맥류 출혈 : 내시경정맥류결찰술, band ligation, 예방적 베타 차단제
- ⑤ 말로리-바이스 증후군 : Bed rest, 수액, 항구토제, 자발적 지혈

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

☞ 환자를 우선 안심시킨 후 어지러움, 호흡곤란 증세 시 응급 상황이니 병원에 오도록 교육합니다.

- ① 피와 관련되었기에 환자 공포감 안심시켜 주기+환자 약제 질문(+ 출혈 경향)
- ② 환자 상태 안정시키기 위해 수액 공급 및 수혈의 필요성 설명하기
- ③ 진단 위해 상부 위장관내시경검사 필요하고 지혈 치료할 수 있음을 설명하기

☞ 응급내시경이 필요한 경우 내시경 전 8시간 금식 유지를 교육합니다.

- ④ 내시경적 지혈 외에도 혈관조영술, 외과적 치료가 필요할 수 있음을 환자에게 설명
- ⑤ 말로리-바이스 증후군 같은 경우 안정 취하고 먹는 것 금함
- ⑥ 모든 상부 위장관 출혈 환자에서 가능한 빨리 상부 위장관내시경 시행하기



keyword

객혈과 감별하기

토혈 양/어지럼증/호흡곤란/소변량 감소 및 수액 필요 유무 파악하기

말로리-바이스 증후군 감별 위해 음주력 물어보기

변 색깔 물어보기

약물력(NSAID, 항응고제 등) 물어보기

신체 진찰 : 간질환 관련 신체 검진(Flapping tremor, 거미혈관종 등) 잊지 않고 시행하기

응급 상황 판단 위해 신체 진찰에서 혈압/맥박 확인하기

식도	정맥류	간 증상, 간 P/E
	MWS	과음
	GERD	속쓰림, 신물
	식도암	체중 감소, 연하곤란, 담배
위	위궤양	속쓰림, 식후 명치 통증 ↑
	십이지장궤양	복통, 식후 명치 통증 ↓
	천공	발열, 오한, 복부 전체 DT/RT
	위암	체중 감소, 소화불량
응고장애		출혈 경향, 항응고제, NSAIDs